

DIARREIA AGUDA



ROTINA CLÍNICA

Material de apoio

RESUMO

- **Definição de diarreia:**

Ocorrência de 3 ou mais evacuações com alteração de consistência (fezes amolecidas ou líquidas) nas últimas 24 horas.

- **Diarreia aguda:**

Apresenta tempo de duração menor do que 14 dias. Sendo que, na prática, a minoria dos pacientes não aguarda todo esse tempo para buscar atendimento médico.



RESUMO

- **Epidemiologia:**

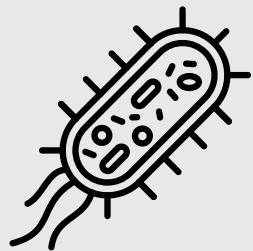
90% dos casos de diarreia aguda têm etiologia viral, sendo caracterizada por gastroenterite viral aguda.

Apenas 10% dos casos de diarreia apresentam etiologia bacteriana, configurando-se como **disenteria**.

- **Microbiologia (principais):**

Viral: Norovírus, Adenovírus, Rotavírus.

Bacteriana: Campylobacter, Shigella, Salmonella, Escherichia coli.



ROTINA CLÍNICA

RESUMO

- **Sinais/Sintomas:**

Gastroenterite viral aguda:

Diarréia aquosa volumosa, náuseas, vômitos e dor abdominal tipo cólica difusa de leve a moderada intensidade.

Quadro autolimitado!

Disenteria:

Diarreia com presença de **muco e/ou sangue** nas fezes, associada a dor abdominal de moderada a forte intensidade, náuseas e vômitos. Pode haver febre.



ABORDAGEM

- **Sinais de alerta/gravidade:**

Idade > 70 anos;

Presença de sangue e muco em várias evacuações;

Paciente imunossuprimido;

Temperatura axilar $>38,5^{\circ}\text{C}$ persistente;

Dor abdominal importante/refratária;

Uso recente de antibiótico (<3meses);

Hospitalização recente;

Sepse.



ABORDAGEM

- **Solicitação de exames:**

NÃO SOLICITAR DE ROTINA!!

Os exames devem ser solicitados diante da presença de sinais de alarme/gravidade.

Via de regra, os pacientes com gastroenterite viral aguda não apresentam sinais de alarme e, portanto, em 90% dos casos, os exames não serão necessários na abordagem destes pacientes.

- **Sobre os exames (racional a ser investigado):**

Distúrbios hidroeletrolíticos (Sódio, potássio, magnésio), Função renal (Ureia e Creatinina), Hemograma (Leucocitose) e marcador inflamatório (PCR).



ROTINA CLÍNICA

TRATAMENTO

- **Racional:**

A base da terapêutica envolve a hidratação adequada, uso de sintomáticos e antimicrobianos (se indicado).

Pacientes com sinais de alarme/gravidade:

Devemos prescrever antibioticoterapia e não podemos utilizar os “famosos” antidiarreicos.

Pacientes com gastroenterite viral aguda:

Podemos utilizar os antidiarreicos e a base do tratamento envolve hidratação adequada e sintomáticos.

Demais detalhes do tratamento estão apresentados nos modelos de prescrição.



ROTINA CLÍNICA

REFERÊNCIAS

- Protocolo Assistencial Pronto Socorro: Gastroenterocolite Aguda - HCOR.
- ACG Clinical Guideline: Diagnosis, Treatment, and Prevention of Acute Diarrheal Infections in Adults.
- Abordagem ao adulto com diarreia aguda em ambientes com abundância de recursos - UpToDate.

